RESUMÃO DO PLANTÃO

CRISE DE ASMA

Puff: Salbutamol (100mcg): 4-10 puffs, 20/20 min em 1h +/- **Brometo de ipratrópio** (20 mcg): 4-8 puffs, 20/20min em 1h

Nebulização: Fenoterol (5 mg/10 mL): 10-20 gotas, com 3 mL de SF 0.9%, NBZ, 20/20min em 1h + **Brometo de ipratrópio** (0,25 mg/mL): 30-40 gotas, diluídas com 3 mL de SF 0.9%, NBZ, 20/20min em 1h

Corticoide: Hidrocortisona 200mg IV OU Prednisona 40-60mg VO

02 se Sat < 94%

Na alta:

- Manter Prednisona por 5-7d, se criança 3-5d
- Iniciar ou realizar o step-up das medicações de controle: Alenia 6/200 - 12/400 e Clenil 200 - 400
- Encaminhamento para posto de saúde

Se precisar IOT: Preferir propofol e quetamina, pelo efeito broncodilatador

Criança: Fenoterol 1gt/3Kg + brometo de ipatrópio 10-20 gotas, repetir em 20min OU Salbutamol (100mcg) 1jato/2-3Kg, repetir em 20 min e Corticoide: Prednisolona (3mg/ml) 1-2mg/kg, VO por 3-5d, max 60mg.

ANAFILAXIA

Cateter periférico calibroso + O2

Adrenalina: IM no vasto lateral da coxa, 5/5min

- Adultos: 0,3 a 0,5mg
- Crianças: 0,01 mg/kg

Corticoide: Hidrocortisona 300mg + SF 0,9% 10 ml, EV, 6/6h

AMIGDALITE

AMOXICILINA 875 MG ---------- 20 COMPRIMIDOS
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS DURANTE 10 DIAS

AMOXICILINA 500 MG ---------- 30 COMPRIMIDOS
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS, DURANTE 10 DIAS

AMOXICILINA + CLAVULANATO (500 + 125 MG) ---------- 30 COMPRIMIDOS
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 08/08 HORAS, DURANTE 10 DIAS

AMOXICILINA + CLAVULANATO (875 + 125 MG) ---------- 20 COMPRIMIDOS
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS, DURANTE 10 DIAS

AZITROMICINA 500 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 01 VEZ AO DIA, DURANTE 03 DIAS

PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI ---------- 01 AMPOLA
USO: APLICAR 01 AMPOLA, INTRA MUSCULAR, DOSE ÚNICA

PNEUMONIA

CURB-65 ≥ 2: Internação

Ambulatorial:

- Amoxacilina 500mg, 8/8h, por 7 dias
- Azitromicina 500mg, 1vez/dia por 5 dias
- Claritromicina 500mg, 12/12h por 7 dias

Se comorbidades: Amoxicilina + clavulanato 875+125 mg, 12/12 horas, por 7 dias OU Levofloxacina 500mg, 12/12h, por 5 dias

Enfermaria (EV):

- Beta-lactâmico (Ceftriaxona 1g 12/12h, por 7-10d) **+** Macrolídeo (Azitro ou Clari)
- Levofloxacino 750 mg, 24/24h, por 5-7 dias;
- Moxifloxacino 400 mg, 24/24h, por 5-7 dias;
- Gemifloxacino 320 mg, 24/24h, por 5-7 dias;

UTI (obrigatório 2 drogas):

- Beta-lactâmico (Ceftriaxona / Ampi-Sulbactam) + Azitro ou Quinolona respiratória

ABSCESSO / LEP

CEFADROXILA 500 MG ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 12/12 HORAS DURANTE 07 DIAS

CEFALEXINA 500 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 06/06 HORAS DURANTE 07 DIAS

SD. GRIPAL

ALLEGRA D 60/120MG---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 12/12 HORAS DURANTE 03 DIAS

LORATADINA 10 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, À NOITE, DURANTE 05 DIAS

SORO FISIOLÓGICO 0,9% ---------- 01 FR
USO: REALIZAR LAVAGEM NASAL, COM UMA SERINGA SEM AGULHA, APLICAR 05-10 ML DE SORO EM CADA NARINA EM TEMPERATURA AMBIENTE 06 VEZES POR DIA ENQUANTO TIVER SINTOMAS

DIPIRONA 500MG ---------- 01 CAIXA
USO: 02 COMPRIMIDOS, VIA ORAL, DE 06/06 HORAS, SE DOR OU FEBRE

PARACETAMOL 750 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 08/08 HORAS, SE FEBRE OU DOR

ANALGESIA ESCALONADA

DIPIRONA 1G ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO VO DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

IBUPROFENO 400 MG ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS, SE DOR

PACO 30 MG ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO VO DE 08/08 HORAS, SE DOR INTENSA

TRAMAL 100 MG ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO VO DE 08/08 HORAS, SE DOR MUITO INTENSA QUE NÃO CESSA AO USO DE PACO

OBS: USAR DRAMIN 20 MINUTOS ANTES

DRAMIN B6 ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO VO DE 08/08 HORAS, SE NÁUSEAS OU VÔMITOS

ENXAQUECA

Analgésicos comuns

Anti-inflamatórios:

- Naproxeno 500 mg VO de 12/12 horas;
- Diclofenaco 50 mg VO de 8/8 horas;
- Cetoprofeno 50 mg VO de 6/6 horas.

Triptanos:

- Sumatriptana (Sumax) 50mg, VO (max 200mg)

CEFALIV ---------- 01 CX
USO: USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, SE ENXAQUECA

ITU

NITROFURANTOÍNA 100 MG ---------- 28 CP
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 6/6 HORAS POR 07 DIAS

MONURIL 3g ---------- 01 CX
USO: DILUIR 01 SACHÊ EM 01 COPO D'ÁGUA E INGERIR ANTES DE DEITAR-SE EM DOSE ÚNICA

AMOXICILINA + CLAVULANATO 500+125MG -------- 21CP
USO: 1 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 8/8 HORAS, POR 7-10 DIAS;

CIPROFLOXACINO 500 MG ---------- 06 COMPRIMIDOS
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS DURANTE 03 DIAS

PYRIDIUM 200 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS EM CASO DE ARDOR AO URINAR

PARALISIA DE BELL

PREDNISONA 20mg _____ 21 COMPRIMIDOS
USO:TOMAR 02 COMPRIMIDOS AO DIA POR 7 DIAS, DEPOIS UM COMPRIMIDO AO DIA POR MAIS 7 DIAS;

QUEIMADURA

SUPERFICIAL: ANALGESIA + CURATIVO

SULFADIAZINA DE PRATA ---------- 01 TUBO
USO: APLICAR NAS LESOES, 12/12H, POR 10 DIAS

PROFUNDA

FÓRMULA DE PARKLAND: RINGER LACTATO AQUECIDO 2 ML X PESO (KG) X SCQ (%). PARA QUEIMADURAS 2 OU 3 GRAU > 20% SCQ EM ADULTOS (> 10% SCQ EM CRIANÇAS), INFUNDIR METADE DO VOLUME TOTAL EM 8 HORAS, E A OUTRA METADE NAS PRÓXIMAS 16 HORAS.

ALERGIA / PRURIDO

POLARAMINE 06 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO VO DE 12/12 HORAS PR 05 DIAS

POLARAMINE 02 MG ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO VO DE 12/12 HORAS, SE PRURIDO (COCEIRA)

HIXIZINE 25 MG ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO VO DE 12/12 HORAS, SE PRURIDO (COCEIRA)

PROMETAZINA 50 MG ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 8/8 HORAS, POR 7 DIAS

LORATADINA 10 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 01 VEZ AO DIA PELA NOITE, DURANTE 05 DIAS

CONJUNTIVITE

TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 1 GOTA 4X/DIA, POR 7 DIAS;

LACRIFILM (COLÍRIO) ---------- 01 FR

USO: PINGAR 02 GOTAS DE 04/04 HORAS NO OLHO ACOMETIDO ENQUANTO DURAR O QUADRO

LAVAGEM DO OLHO COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% 4 VEZES AO DIA. APÓS ABERTO, O SORO DEVE SER CONSERVADO EM GELADEIRA.

CONSTIPAÇÃO

LACTULONA ---------- 01 FRASCO
USO: 15 ML, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS, SE PRISÃO DE VENTRE

ÓLEO MINERAL ---------- 01 FRASCO
USO: 01 COLHER DE SOPA, VIA ORAL, DE 12 EM 12 HORAS

FLORATIL 200 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS DURANTE 03 DIAS

SIMETICONA 40 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 08/08 HORAS

BUSCOPAN COMPOSTO ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS, SE DOR ABDOMINAL

GASTROENTERITE

BUSCOPAN COMPOSTO ---------- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO VO DE 06/06 HORAS, SE DOR ABDOMINAL

BUSCOPAN SIMPLES ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 08/08 HORAS, SE DOR ABDOMINAL

DRAMIN B6 ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS, SE NÁUSEAS OU VÔMITOS

VONAU 40 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 08/08 HORAS, SE NÁUSEAS OU VÔMITOS

PLASIL 10 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 08/08 HORAS, SE NÁUSEAS OU VÔMITOS

BROMOPRIDA 10 MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 08/08 HORAS, SE NÁUSEAS OU VÔMITOS

FLORATIL 100MG ---------- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12 EM 12 HORAS

FLORAX ---------- 01 CAIXA
USO: 01 FRASCO, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS DURANTE 03 DIAS

SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL ---------- 02 SACHÊS
USO: DILUIR 01 SACHÊ EM 01 LITRO DE ÁGUA E TOMAR 200ML APÓS CADA EPISÓDIO DE DEJEÇÃO DIARREICA

CIPROFLOXACINO 500 MG ---------- 10 COMPRIMIDOS
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS DURANTE 05 DIAS

ALBENDAZOL 400MG ---------- 03 CP
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, UMA VEZ AO DIA, POR 03 DIAS

LOPERAMIDA 2 MG ---------- 1 CAIXA
USO: INICIAR COM 4 MG VO, SEGUIDO DE 2 MG APÓS CADA EVACUAÇÃO LÍQUIDA (DOSE MÁXIMA: 16 MG/DIA).

AUMENTAR A INGESTA HÍDRICA

EVITAR ALIMENTOS A BASE DE LEITE

ALIMENTAÇÃO LEVE

PROCURAR UNIDADE DE EMERGÊNCIA SE PIORA OU MANUTENÇÃO DO QUADRO

DISPEPSIA/REFLUXO

OMEPRAZOL 20 MG ---------- 60 COMPRIMIDOS

USO: 02 COMPRIMIDOS, VIA ORAL, EM JEJUM PELA MANHÃ DURANTE 30 DIAS

PANTOPRAZOL 20 MG ---------- 01 CX

USO: 01 COMPRIMIDO VO 12/12 HORAS POR 10 DIAS, APÓS ESSE PERÍODO, 01 COMPRIMIDO VO EM JEJUM PELA MANHÃ POR 20 DIAS

DOMPERIDONA 10 MG ---------- 01 CAIXA

USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 03 VEZES AO DIA 30 MINUTOS ANTES DAS REFEIÇÕES DURANTE 10 DIAS

EVITAR INGESTA DE CAFÉ, REFRIGERANTES, ALIMENTOS ENLATADOS E GORDUROSOS

EVITAR TEMPO PROLONGADO EM JEJUM

AUMENTAR INGESTA DE ÁGUA

ESCABIOSE / PEDICULOSE

POLARAMINE 06 MG ---------- 01 CAIXA

USO: 01 COMPRIMIDO VO DE 12/12 HORAS PR 05 DIAS

IVERMECTINA 06 MG ---------- 02 CX

USO (<65 KG): 02 COMPRIMIDOS VO DOSE ÚNICA

USO (>65 KG): 02 + ½ COMPRIMIDOS VO DOSE ÚNICA

BENZOATO DE BENZILA (SABONETE) ---------- 01 UN

USO: TÓPICO, LAVAR A PELE PRODUZINDO ESPUMA E DEIXANDO SECAR NO CORPO. REMOVER NO DIA SEGUINTE. REPETIR O USO 03 VEZES EM DIAS ALTERNADOS

PERMETRINA À 5% ---------- 01 TB

USO: TÓPICO, APLICAR NA PELE LIMPA E SECA, MASSAGEAR O PRODUTO NA PELE, DESDE A CABEÇA ATÉ OS PÉS, PRINCIPALEMNTE NAS REGIÕES ONDE MAIS APRESENTA LESÕES. NÃO APLICAR EM MUCOSAS OU PROXIMO DOS OLHOS. DEIXAR AGIR DURANTE 10 MINUTOS E ENXAGUAR. REPETIR O USO DURANTE 07 DIAS

TVP

Anticoagulação com Varfarina

- **Heparina por 5-10 dias**
  HNF: Ataque 333 X peso + manutenção 250 x peso
  Enoxaparina: 1mg/kg sc, 12/12h
- **Varfarina** 2,5-10mg/dia VO, as 18h, por pelo menos 3 meses + dosagem de RNI
- *RNI deve se manter entre 2-3*

Novos anticoagulantes orais

RIVAROXABANA 15 MG ---------- 42 COMPRIMIDOS
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 12/12H, POR 3 SEMANAS

RIVAROXABANA 20 MG ---------- 3 CAIXAS
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, UMA VEZ AO DIA, POR 3 MESES

CANDIDÍASE

FLUCONAZOL 150 MG ---------- 01 COMPRIMIDO
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DOSE ÚNICA

MICONAZOL 2% CREME ---------- 07 APLICADORES
USO: 01 APLICADOR CHEIO, VIA VAGINAL, 01 VEZ POR DIA, POR 7 DIAS

IAM

Paciente com queixa de SCA: realizar **ECG e dosar MNM** (troponina, CKMB, CPK) para diferenciar

- **Oxigênio** (Se SatO2 < 90%, inicie com 4L)
- **AAS 300mg** mastigável ou retal (CI: Alergia importante e Hemorragia digestiva ativa ou recente)
- **Clopidogrel 300mg,** se > 75 anos – 75mg
- **Nitroglicerina** (tridil) sublingual ou translingual, até 3 comprimidos a cada 3-5min (CI: IAM de parede inferior ou IAM de VD, paciente hipotensos, bradicardicos ou taquicardicos e uso de sildenafil ou vardenafil nas últimas 24h)
- **Opiodes (morfina):** se dor refratária ao Tridil
- **Heparina** (HNF ou HBPM): Associada a Angioplastia e tratamento fibrinolítico

Tratamento acessório após 24h: Beta-bloq, IECA/BRA, estatina

AVC

Avaliar déficit: escala CCPS - avaliar paralisia facial (pedir ao paciente para sorrir), queda do braço (pedir ao paciente para estender os braço e fechar os olhos) e fala normal (pedir ao paciente para repetir "não dá para perder os velhos hábitos").

Estabelecer **horário de início de sintomas**

Controlar PA

- Se candidato a fibrinólise: PA < 185X100mmHg
- Se isquêmico sem fibrinólise: 220x120mmHg
- Se hemorrágico: PAS < 160mmHg

Controlar glicemia, temperatura e sódio

Regular para tomografia de crânio sem contraste

PARAMETROS VENTILATÓRIOS

VCV

- Volume corrente 6mlKg do preso predito
- FC 12-20
- I:E 1:2
- PEEP 5

PCV

- Pressão inspiratória: 12-20
- Tempo inspiratório: 0,8 – 1,2s

DROGAS DE INTUBAÇÃO

INDUÇÃO

Etomidato: 0,3mcg/Kg. 01 ampola de 20mg/ml

Midazolam: 0,3mcg/Kg. 01-2 ampola de 5ml/ml

Quetamina: 1,5-2mg/Kg. 1-2 ampolas de 50mg/ml. Diluir em 8ml de SF

Propofol: 1,5-2mg/Kg.

Fentanil: 2-3mcg/Kg. Ampolas de 50mcg/1ml

Succinilcolina: 1-1,5mg/Kg. 0,5-1 ampola de de 100mg. Diluir em 09ml SF0,9%. Fazer 1ml/Kg. *OBS: Hipercalemia*

Rucoronico: 1mg/Kg. Ampola de 10mg/ml

DROGAS VASOATIVAS

Qual a diluição padrão?

Noradrenalina: 0,01 a 3mcg/kg/min

Adrenalina: 0,1 - 0,5mcg/kg/min (droga muito arritmogênica)

Dopamina: usada em hipotensão associado a bradicardia. Tem efeito em b1 e alfa 1, depende da dose. Vasodilatador esplênico, cerebral e renal

Vasopressina 0,01 a 0,04UI/kg/min. Receptor v1 (musculatura vascular) e v2 (ação renal). Usado como adjuvante da nora! Não a valor fixo, porém tende a adicionar quando nora 0,3-0,5. *Desmamar primeiro a nora!*

Dobutamina 5-20mcg/kg/mim. Choque cardiogênico. Receptor b1 e b2, aumento cronotripismo e inotroprismo

Nitrato (niprid): 2,5 a 20mg/kg. Ação veno e arterial dilatoradora. Melhor controle pressórico. Atentar para intoxicação por cianeto. Pode ser feito em periférico!

Nitroglicerina (tridil) – ação venodilatadora, bom dilatador coronariano

EMERGENCIA HIPERGLICEMICA

Cetoacidose Diabética (2 critérios)

- pH < 7,3
- BIC < 18
- Cetonúria
- HGT > 250

Volume (cristaloide): 1000 SF 0,9%

Dosar eletrólitos (Na e K)

Potássio:

- <3,5 Repoe potassio e dps de 2h reavalia
- <3,5 a 5,1 Faz insulina enquanto repoe potassio
- >5,1 poe só a insulina mesmo

Sódio (Calcular sódio real)

100 HGT > 100 - multiplica por 1,6

Se tiver hipernatremia, faz com SF 0,45

Insulinização: insulina regular, 100UI (01 ampola) em 100mL de SF 0,9 na bomba, o que dá uma solução de 1UI/ml. 0,1UI/kg/hora em BIC + bolus de 0,1UI/Kg/h

Medir HGT de 1/1h: Queremos que desça de 50-70/hora. Se acima, diminui vazão da insulina. Se abaixo, aumenta a vazão. Sempre diminui e aumenta pela metade/dobro.

Chegou nos HGT 250, adiciona SG 5% 500mL em 24h

Chegou em HGT 200, reduz a vazão pra 0,05 UI/kg/h, adiciono NPH e libero dieta.

Se pH > 7,3; BIC > 18; HGT > 250, DESLIGO BIC.

Estado hiperosmolar é igual só muda que:

- Normalmente idosos desidratados
- HGT > 600
- Osmolaridade como parâmetro: Osm > 320

CONVULSÃO

DIAZEPAM 10MG IV OU IM, ATÉ 3X

HIDANTAL 4AMPOLAS DILUÍDO EM 250 SF, correr em 30min. Manutenção 100mg, 8/8h

FENOBARBITAL 10MG/KG

Se não responder: IOT

INTOXICAÇÃO POR ALCOOL

SEM HIPOGLICEMIA

SG 5% 1000ML, IV + METOCLOPRAMIDA 10MG IV, 8/8H

SE HIPOGLICEMIA

6-10 AMPOLAS DE GLICOSE 50%ML EM BÓLUS

ETILISTA CRONICO: 100MG DE TIAMINA IM OU EV

INTOXICAÇÃO

Intoxicação por benzodiazeínico: Flumazenil

Intoxicação por opioide: Naloxona